Medicamentos por Aula

Nov 12, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

Os medicamentos de cada aula na ordem em que se usam: primeira linha, depois as seguintes. Em cada um, o que não pode esquecer e um gancho para memorizar. As doses e as linhas são as das apostilas.

Aula 3. Depressão

A aula não numera linhas na depressão: ela manda escolher pelo sintoma que predomina. A ordem abaixo vai do mais usado ao reservado para quando nada funciona.

Gancho da escolha: "Sente demais, sem gasolina, nada interessa". Sente demais (choro, ansiedade) pede serotonina; sem gasolina (sem energia) pede dopamina; nada interessa (sem interesse, sem foco) pede noradrenalina.

Degrau 1. ISRS (inibidores seletivos da recaptação de serotonina)

Demoram 6 a 8 semanas, porque os autorreceptores precisam se dessensibilizar. Efeitos de todos: hiponatremia, QTc longo, sangramento, embotamento e disfunção sexual. **Gancho dos efeitos: "HQ SEDI".**

1. **Fluoxetina, 20 a 80 mg.** Está no SUS e é aprovada para criança e gestante; meia-vida longa; tira o apetite no início. *Gancho: "FLUi para todo lado".*
2. **Sertralina, 50 a 200 mg.** Gestação, amamentação e cardíaco; poucas interações. *Gancho: "SERTA para o coração e o bebê".*
3. **Escitalopram, 10 a 20 mg.** Fração ativa do citalopram, mais potente. Acima de 85 anos, máximo de 15 mg (QTc e hiponatremia).
4. **Citalopram, 20 a 40 mg.** Menos potente. Acima de 85 anos, máximo de 30 mg. *Gancho: "85 anos: cita 30, escita 15".*
5. **Paroxetina, 20 a 60 mg.** A mais serotoninérgica e a de mais efeitos: mais ganho de peso e disfunção sexual. *Gancho: "PARa a vida sexual".*
6. **Fluvoxamina, 100 a 300 mg.** Usada sobretudo no TOC.

Cuidado comum: fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina têm mais interações, principalmente com tricíclicos.

Degrau 2. IRSN (inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina)

Para quem tem pouco afeto positivo (sem energia, sem interesse) e menos afeto negativo. Todos podem dar síndrome de retirada (insônia, náusea, tontura, sensação de choque, quadro gripal).

1. **Venlafaxina, 75 a 225 mg (até 300).** Muito potente. Abaixo de cerca de 150 mg só age na serotonina. Sobe a pressão, dá sudorese e tem a retirada mais forte. *Gancho: "VENLA só vira dupla depois dos 150".*
2. **Desvenlafaxina, 50 a 200 mg.** Quase sem interação; menos disfunção sexual; trata fogachos. *Gancho: "DES-complicada".*
3. **Duloxetina, 60 a 120 mg (dor a partir de 30 mg).** Trata dor crônica e neuropática mesmo sem depressão; piora doença hepática e combina mal com álcool. *Gancho: "DULOr".*

Degrau 3. Outros antidepressivos (escolhidos pelo perfil)

- **Bupropiona, 150 a 300 mg.** Dopamina e noradrenalina: falta de energia, tabagismo, disfunção sexual pelo ISRS. *Gancho: "BUP = BUsca energia e Para de fumar".*
- **Mirtazapina, 30 a 45 mg (até 60).** Bloqueia o alfa 2: depressão com insônia; dá sono e engorda. Com venlafaxina forma o "combustível de foguete da Califórnia". *Gancho: "MIRTA engorda e faz dormir".*
- **Trazodona.** Insônia, 25 a 150 mg; depressão, 150 a 375 mg (Contramid). Depressão com ansiedade e insônia. *Gancho: "TRAZ o sono".*
- **Vilazodona, 20 a 40 mg.** Depressão ansiosa; tomar com comida.
- **Vortioxetina, 10 a 20 mg (até 30).** Queixa de memória e concentração; náusea. *Gancho: "VORTEX da cognição".*
- **Agomelatina, 25 a 50 mg.** Ritmo do sono; monitorar o fígado.

Os que poupam a vida sexual: bupropiona, trazodona, vilazodona, vortioxetina e desvenlafaxina.

Degrau 4. Tricíclicos

Amitriptilina (forte nos dois), nortriptilina (menos efeitos), imipramina (enurese), clomipramina (TOC). Para depressão, 75 mg ou mais. **Riscos, gancho "CIEA":** Coração (arritmia, QTc), Interações, Epilepsia (convulsão), Anticolinérgico no idoso. **Usos em dose baixa, gancho "DICE":** Dor, Intestino irritável, Cefaleia, Enurese.

Degrau 5. Depressão resistente

1. **Antipsicótico associado** (aripiprazol, brexpiprazol, quetiapina, olanzapina, risperidona). Das estratégias mais estudadas; o preço é peso, prolactina, rigidez e QTc.
2. **Lítio associado.** Antissuicídio e pode encurtar a latência; fora do TAB não precisa de litemia terapêutica, mas deve ser monitorado. Não é primeira, segunda nem terceira linha na depressão aguda.

3. **ECT (eletroconvulsoterapia).** Refratária, intolerância a remédio, risco iminente de suicídio. Sem contraindicação absoluta. *Gancho "38, 61, 81": queda da ideação suicida em 1 semana, 2 semanas e ao final.*
4. **Escetamina.** Resistente ou alto risco de suicídio; dose subanestésica, **sempre com antidepressivo**, em ambiente controlado. Bloqueia o NMDA e aumenta o BDNF.
5. **EMT (estimulação magnética transcraniana).** Acordado e sem convulsão; menos eficaz que a ECT.

Aula 4. Transtorno bipolar

Regra que vale para todas as fases: lítio e quetiapina são o padrão ouro, aprovados para todas as fases; a monoterapia é rara, e quando funciona costuma ser com um dos dois. **Gancho: "LQ é ouro".** Evite antidepressivo ao máximo: ele traz instabilidade, estado misto e ciclagem rápida.

Mania e manutenção

1. **Lítio.** Estabiliza, protege o neurônio e reduz suicídio. Na mania, litemia de cerca de **1,0 mEq/L**.
   - Litemia 1 semana após iniciar, colhida **12 horas** após a dose; semanal até estabilizar, mensal por 2 a 3 meses, depois trimestral.
   - Pedir a cada 3 meses: litemia, TSH, creatinina e cálcio. *Gancho: "L TCC".*
   - Sobem a litemia: diuréticos, anti-inflamatórios e IECA (relatos com metronidazol e propranolol). *Gancho: "DIA".*
   - Urina demais: investigar diabetes insípido. Na gestação, uso controverso (risco baixo de malformação cardíaca) e litemia mensal.
2. **Quetiapina.** Todas as fases; escolha na gestante bipolar; pode falhar na mania grave, porque se liga fraco ao D2.
3. **Ácido valproico (valproato, divalproato).** Mania aguda e manutenção; o melhor em **ciclagem rápida, estado misto e ansiedade**. Começa com 250 mg e sobe a cada 2 dias até 750 a 1800 mg (até 3 g); guiado pela clínica, sem precisar dosar. Mal-estar gástrico; rash obriga suspender; **teratogênico**, proscrito em mulher fértil sem controle. *Gancho: "VALPROato VALE para mania e misto".*
4. **Carbamazepina.** Mania e manutenção como **segunda linha**; não serve para depressão; muitas interações e menor evidência. *Gancho: "CARBA = carga de interações".*

Depressão bipolar

1. **Lítio, quetiapina, lamotrigina ou lurasidona.**

    - **Lamotrigina:** aprovada só para a depressão bipolar. Começa com 25 mg e sobe a cada 2 semanas (pode dobrar), até 200 a 400 mg. Pode virar mania, então associe outro estabilizador. *Gancho: "LAMOtrigina, LÁ embaixo, sobe devagar".*
    - **Lurasidona:** na manutenção, só associada a algo que previna a virada. A dupla **lítio com lurasidona** serve a quem tem mais episódios depressivos.
2. **Valproato** em segunda linha (eficaz menos na depressão).
3. **Olanzapina com fluoxetina: terceira linha**, com muito cuidado, no paciente muito deprimido. Se usar antidepressivo no episódio, **retire na manutenção**.

Nunca associe lamotrigina com valproato: o risco de rash grave, inclusive Stevens Johnson, aumenta muito.

Aula 5. Comportamento suicida

A aula não trata o suicídio com um remédio de primeira linha: trata a doença de base e usa o que reduz o risco diretamente. A ordem aqui é da ação mais rápida para a de longo prazo.

1. **ECT (eletroconvulsoterapia).** Age direto na ideação suicida, em casos graves e resistentes.
2. **Escetamina.** Também age direto, nos mesmos casos; sempre com antidepressivo.
3. **Lítio.** Redução de suicídio comprovada, com ação relativamente mais rápida que outros estabilizadores.
    - Exige litemia periódica, porque a janela terapêutica é estreita e há risco de intoxicação.
    - Mecanismo ainda não totalmente conhecido, apesar de mais de 40 anos de uso.
    - É pouco usado na prática por menor divulgação, monitoramento frequente, efeitos adversos e manejo complexo.

Gancho: "ECT e escetamina apagam o incêndio; o lítio é o extintor que fica na parede".

Medidas não farmacológicas que a prova cobra junto: restringir pesticidas e armas, vender remédios em embalagens menores e notificar toda tentativa no SINAN.

Aula 6. Psicoses

A base de todos: bloqueiam o receptor D2 da dopamina. Na via mesolímbica isso trata delírio e alucinação; na nigroestriatal causa rigidez; na tuberoinfundibular sobe a prolactina; na mesocortical, em dose alta, piora os sintomas negativos. Os atípicos bloqueiam também o 5-HT2A e fazem menos disso. **Gancho: "típico endurece, atípico engorda".**

A aula não fixa qual antipsicótico é o primeiro; ela define a escada: **antipsicótico comum, depois clozapina, depois ECT**.

Degrau 1. Antipsicóticos atípicos

- **Risperidona, 1 a 8 mg.** "O mais típico dos atípicos". A paliperidona é seu metabólito ativo.
- **Olanzapina, 5 a 20 mg (até 30).** Quase sem rigidez; seda (ajuda o sono); engorda muito. *Gancho: "OLANZA seda e engorda".*
- **Quetiapina, 400 a 800 mg na esquizofrenia.** Menos potente. Em dose baixa só dá sono (histamina); em dose média tem ação antidepressiva; só em dose alta é antipsicótica. Também serve ao TAB em todas as fases, à gestante bipolar, ao delirium e aos sintomas da demência. *Gancho: "QUETIA muda com a dose".*
- **Ziprasidona, 80 a 160 mg.** Bom perfil metabólico, pode ser menos eficaz; tomar com refeição de cerca de 500 kcal.
- **Aripiprazol.** Agonista parcial: dá cerca de 1/3 do sinal da dopamina, baixando onde há excesso. Excelente perfil metabólico; o efeito marcante é a **acatisia** (inquietação). Também serve ao TAB e potencializa a depressão. *Gancho: "ARIPIPRAZOL não engorda, mas não deixa parar quieto".*
- **Brexpiprazol.** Agonista parcial com mais ação serotoninérgica; na esquizofrenia precisa de dose alta; também na depressão e na demência.

Degrau 1. Antipsicóticos típicos

- **Haloperidol.** Alta potência, está no SUS. Oral, injetável de ação imediata (agitação) e **depósito a cada 2 a 4 semanas**. Muita rigidez. *Gancho: "HALO forte".*
- **Trifluoperazina e zuclopentixol.** Também alta potência.
- **Clorpromazina e levomepromazina.** Baixa potência: sedam, baixam a pressão e têm efeito anticolinérgico. *Gancho: "baixa potência, alto SHA" (Sedação, Hipotensão, Anticolinérgico).*
- **Periciazina.** Possível benefício cognitivo.

Degrau 2. Clozapina

Para a **esquizofrenia refratária**: falha de 2 antipsicóticos em dose moderada a alta e por semanas. Baixa afinidade pelo D2.

- Efeito comum: **constipação**. Efeito raro e grave: **neutropenia (agranulocitose)**.
- Hemograma **semanal nas 18 primeiras semanas, quinzenal nas 18 seguintes e mensal enquanto usar**. *Gancho: "18 e 18".*
- Também é a troca na discinesia tardia, para dar descanso ao D2.

Degrau 3. ECT de manutenção

Quando nem a clozapina responde, ou quando ela causa sedação excessiva, efeito anticolinérgico importante ou neutropenia.

Os dois efeitos graves

- **Discinesia tardia:** movimento involuntário após mais de 1 ano de uso; pode ser irreversível. Trocar para clozapina.
- **Síndrome neuroléptica maligna:** febre, rigidez, consciência flutuante, pressão e pulso instáveis, rabdomiólise e leucócitos altos, geralmente após dose alta. Suporte intensivo.

Aula 7. Ansiedade

Gancho geral: "ISRS trata, benzodiazepínico socorre". O ISRS age devagar e pode piorar a ansiedade no início, então começa em dose baixa; o benzodiazepínico age rápido, mas só serve como ponte ou resgate.

TAG (transtorno de ansiedade generalizada)

Primeiro decida pela gravidade: leve, só TCC; moderado, TCC ou remédio; grave, TCC **e** remédio. Reavaliar em 4 a 6 semanas.

1. **ISRS: escitalopram, sertralina ou paroxetina.**
2. **IRSN: venlafaxina ou duloxetina.** Venlafaxina começa baixa (alguns não toleram o efeito noradrenérgico) e tem retirada mais forte.
3. **Pregabalina**, em casos selecionados.
    - Fecha a subunidade α2δ do canal de cálcio e reduz glutamato, noradrenalina e substância P; **não age no GABA**.
    - Age mais rápido que o ISRS; útil na intolerância ou falha dos antidepressivos.
    - Duas tomadas por dia; eliminação renal, ajustar na insuficiência renal.
    - Tontura e sono; quedas no idoso; edema; peso em dose alta.
    - Associada ao ISRS na resposta parcial: sintomas físicos, bruxismo ou ISRS que não pode subir.
    - *Gancho: "PREGA a porta do cálcio".*
4. **Buspirona.** Agonista parcial 5-HT1A; semanas para agir; 2 a 3 tomadas por dia; não vicia (útil em quem tende a abusar); trata bruxismo pelo ISRS. *Gancho: "BUSPIRONA não vicia, mas não socorre".*

Ponte para a insônia no início: alprazolam ou clonazepam em dose baixa e por pouco tempo, ou pregabalina em dose baixa.

Manutenção: no mínimo 6 meses, idealmente 12, **sem reduzir a dose**. Recaída de cerca de 20% com manutenção e de 50% sem.

Pânico

Primeira linha: **psicoterapia (TCC) somada a remédio**.

1. **ISRS**, começando em dose muito baixa e avisando sobre a piora inicial.
2. **Venlafaxina** (o IRSN eficaz no pânico).
3. **Benzodiazepínicos: alprazolam e clonazepam**, sobretudo no início. Fixo se as crises forem muito frequentes; resgate se forem espaçadas. Sempre dizer que são temporários. Lorazepam tem menos evidência.
4. **Tricíclicos: imipramina e clomipramina**, também eficazes.
5. **Pregabalina**, se não houver sintomas depressivos.

Não funciona: buspirona. Retirar só após remissão completa e pelo menos 1 ano funcionando bem.

Ansiedade social e agorafobia

- **Ansiedade social:** TCC como principal; remédio como nos outros ansiosos, com **antidepressivo em primeira linha**.
- **Agorafobia:** o remédio ajuda, mas o essencial é a terapia de exposição.

Fobia específica

Não há remédio específico eficaz. Primeira linha é a terapia de exposição; remédio só para as comorbidades.

Benzodiazepínicos: qual e quando

Remédio	Uso	Gancho
Clonazepam, alprazolam	Ansiedade e pânico	Os ansiolíticos
Midazolam, flunitrazepam	Sono e sedação	Os hipnóticos
Diazepam	Convulsão e abstinência alcoólica	Entra rápido no cérebro
Clobazam	Anticonvulsivante com menos sedação	

Remédio	Uso	Gancho
Lorazepam	Doença do fígado	"LORA LIVRA o fígado": conjugação direta
Zolpidem (não é benzodiazepínico)	Só para iniciar o sono	Age na subunidade α1; sem efeito ansiolítico

Subunidades do GABA-A, gancho "1 dorme, 2 e 3 acalmam, 5 esquece". Riscos: dependência, tolerância, quedas e depressão respiratória com outros depressores. Latência de sono de até 30 minutos é normal e não pede hipnótico.

Aula 8. TOC e espectro

O ideal é remédio somado à exposição com prevenção de resposta. O remédio baixa a ansiedade e a força das obsessões, mas a melhora que dura depende de o paciente não fazer o ritual.

Gancho da escada: "S, C, A, G, C" = ISRS, Clomipramina, Antipsicótico, Glutamatérgico, Cirurgia. Cada degrau corresponde a uma hipótese: serotonina baixa, dopamina alta, glutamato alto.

TOC

1. **ISRS (primeira linha).** Todos funcionam; citalopram e escitalopram não têm aprovação formal da FDA para TOC, mas são usados. Fluvoxamina é a clássica.
   - **Dose alta**: doses baixas falham; subir até a máxima tolerada.
   - **Resposta em 12 a 20 semanas**; mesmo após chegar à dose máxima em cerca de 3 meses, a melhora ainda pode vir. Poucas semanas sem resposta não é falha.
   - *Gancho: "no TOC, ISRS alto e paciência longa".*
2. **Clomipramina.** O tricíclico mais serotoninérgico; alguns estudos o acham superior aos ISRS. Limitado pelos efeitos anticolinérgicos e cardíacos.
3. **Antipsicótico associado ao ISRS** na resposta parcial ou refratariedade: **risperidona ou aripiprazol**, inclusive em crianças. Reduz o excesso de dopamina.
4. **Glutamatérgicos nos refratários:** memantina (bloqueia o NMDA) ou lamotrigina.
5. **Tratamento invasivo**, só após falha de TCC com remédio adequado: capsulotomia anterior ou cingulotomia (radiofrequência ou Gamma Knife), estimulação cerebral profunda ou estimulação magnética transcraniana profunda.

Não use IRSN: não são aprovados para TOC e têm menos evidência.

Transtornos do espectro

- **Dismórfico corporal e acumulação:** tratamento semelhante ao do TOC.
- **Tricotilomania:**
  1. Terapia de reversão de hábitos (principal).
  2. **N-acetilcisteína acima de 2 g por dia**, a opção mais promissora; modula o glutamato e reduz a impulsividade; estudos pequenos.
  3. Clomipramina, com evidência limitada.
  - **Funcionam mal:** ISRS em dose alta e antipsicóticos.
- **Escoriação:** reversão de hábitos; N-acetilcisteína com evidência limitada.

Gancho: "cabelo e pele: hábito e NAC; obsessão: exposição e ISRS alto".

Aula 9. Trauma e estressores

TEPT (transtorno de estresse pós-traumático)

A primeira linha do TEPT é a **psicoterapia**, com a exposição prolongada como primeira escolha. Entre os remédios:

1. **ISRS (primeira escolha farmacológica).** Atuam na ansiedade, no humor e na reexperiência do trauma.
2. **Doxazosina** (a prazosina tem mais evidência, mas não existe no Brasil). Bloqueia o alfa 1 adrenérgico; indicada para **pesadelos e sintomas noturnos**.
3. **Propranolol.** Bloqueia o beta adrenérgico; ajuda na **hiper-reatividade**.
4. **Terapia assistida por MDMA.** Experimental no Brasil; só em ambiente terapêutico controlado.

Gancho dos adrenérgicos: "Alfa para o sonho, Beta para o susto".

Proibido: benzodiazepínico no primeiro mês após o trauma. Além do risco de abuso, ele apaga a ansiedade sem tirar o estresse por baixo, e a memória do trauma acaba gravada com mais força no hipocampo. *Gancho: "BZD cala o alarme, mas grava o incêndio".*

Estresse agudo

- **Para a insônia:** quetiapina, trazodona, anti-histamínicos ou antipsicóticos de baixa potência; **evitar benzodiazepínicos**.
- **Para intrusivos e sono:** doxazosina ou prazosina.

Transtorno de adaptação

Psicoterapia e rotina com higiene do sono. Remédio só conforme o sintoma que predomina; **nenhum tem boa evidência específica**.

Luto prolongado

A terapia de luto prolongado de Katherine Shear é o tratamento. Remédio só como suporte, sobretudo se houver depressão ou ansiedade; **não há evidência robusta** para o luto em si.

Transtornos da infância (apego reativo e interação social desinibida)

Não há remédio na aula: psicoterapia e, principalmente, um cuidador estável, previsível e responsivo.

Aula 10. Somatoformes e dissociativos

Gancho da aula inteira: "aqui a terapia trata e o remédio só ajuda". Em todos estes quadros a psicoeducação e a psicoterapia vêm primeiro, e o remédio entra como adjuvante ou para as comorbidades.

Quadro	Primeira linha	Remédio	O que não esquecer
Sintomas somáticos	Psicoeducação, TCC e consultas regulares e programadas com exame físico	**ISRS** como adjuvante, para ansiedade e preocupação com o corpo	Evitar exames invasivos e cuidado com achados incidentais
Ansiedade de doença	Psicoeducação e TCC	**ISRS** como adjuvante	Consultas frequentes são controversas: podem reforçar o medo
Conversivo (sintomas neurológicos funcionais)	Psicoeducação e psicoterapia	**Nenhum remédio trata o sintoma**; só as comorbidades (depressão, ansiedade)	Nunca dizer "é psicológico" ou "não é nada"
Factício	Manejo clínico para evitar dano	Nenhuma terapia comprovada	Prognóstico reservado; vigiar a contratransferência da equipe

Quadro	Primeira linha	Remédio	O que não esquecer
Amnésia dissociativa	Psicoeducação, ambiente seguro e psicoterapia	Só para comorbidades	Hipnose é controversa; recuperar a memória não é obrigatório
Despersonalização e desrealização	Psicoeducação e TCC	1. **ISRS** se houver ansiedade ou depressão. 2. **Lamotrigina** nos sintomas dissociativos persistentes	Excesso de ISRS pode causar despersonalização: lembrar no diferencial

Gancho do conversivo: "o sintoma é real, a lesão não existe, e não há comprimido para ele".

Aula 11. Transtornos de personalidade

O tratamento principal é psicoterápico. O remédio quase não muda a estrutura da personalidade: serve para aliviar sintomas ou tratar comorbidades. *Gancho: "remédio não muda jeito de ser".*

Cluster A (paranoide, esquizoide, esquizotípico)

1. **Antipsicóticos**, para desconfiança, distorções de percepção, pensamento excêntrico ou psicose passageira. A evidência é limitada, mas são usados na prática.

Cluster B

Antissocial

- Nenhum remédio trata o transtorno em si.
- Para agressividade, impulsividade ou irritabilidade: **antipsicótico ou estabilizador do humor, como o ácido valproico**.
- Psicoterapia também sem eficácia comprovada no adulto; mais chance com intervenção no transtorno de conduta antes dos 15 anos.

Borderline

1. **Terapia comportamental dialética**: forte evidência e principal tratamento. Reduz impulsividade, automutilação, suicídio e instabilidade.
2. **Remédio só para o sintoma e pelo menor tempo possível:** antidepressivo, antipsicótico ou estabilizador, conforme o que predomina.

3. **Ômega 3, cerca de 2 g por dia** (mais EPA que DHA): pode ajudar depressão e suicidalidade; evidência baixa.
4. **Lisdexanfetamina:** um estudo sugeriu melhora, mas pode ter sido TDAH junto; não é evidência robusta.

Benzodiazepínico: NÃO. Risco de abuso, dependência e piora da impulsividade. *Gancho: "borderline sem BZD".*

Narcisista e histriônico: sem remédio na aula e sem evidência robusta de psicoterapia específica.

Cluster C (evitativo, dependente, obsessivo compulsivo)

1. **Psicoterapia**: o cluster com melhor resposta.
2. **ISRS no evitativo**, para a ansiedade.
3. Dependente e obsessivo compulsivo: **sem benefício consistente** de remédio.

Gancho final: "A toma antipsicótico; B borderline faz TCD e nunca BZD; C responde à terapia, e o evitativo ao ISRS".

Aula 12. Transtornos alimentares

Gancho dos aprovados: "Bulimia FLUi, Compulsão LISa, Anorexia OLHA sem aprovação". Fluoxetina é a única aprovada pela FDA para bulimia; lisdexanfetamina, a única para compulsão; a anorexia não tem remédio aprovado e usa olanzapina.

Anorexia nervosa

1. **Reabilitação nutricional** com metas individuais de ganho de peso. Começar com **5 a 20 kcal/kg/dia** e monitorar fósforo, potássio, magnésio, sódio, glicemia, volêmia e ECG, pelo risco de síndrome de realimentação.
2. **Psicoterapia focada no transtorno alimentar** (adultos) e **terapia familiar** (jovens com cuidador).
3. **Olanzapina:** o antipsicótico mais usado; promove ganho de peso (por apetite e por efeito metabólico) e reduz obsessão e ansiedade.

Os estudos de remédio na anorexia são poucos, curtos e pequenos.

Transtorno de compulsão alimentar

1. **Primeira linha: TCC ou terapia interpessoal**, individual ou em grupo.

2. **Segunda linha** (prefere remédio ou não respondeu): **antidepressivos** (fluoxetina, bupropiona), que ajudam pela impulsividade, ansiedade e humor, mas pouco no peso; ou **lisdexanfetamina**, única aprovada, que modula a recompensa e o controle inibitório. Na prática, TCC somada a remédio é o mais eficaz.
3. **Terceira linha e alternativas:**
    - **Topiramato:** reduz compulsão e peso, bom na obesidade; deixa o pensamento lento.
    - **Naltrexona com bupropiona:** aprovada para obesidade, não para compulsão; melhor quando somada à TCC.
    - **Sibutramina:** papel secundário; risco cardiovascular, pressão alta e taquicardia.
    - **Agonistas de GLP-1:** promissores, mas ainda não são tratamento estabelecido.

Não esqueça: lisdexanfetamina não é remédio para emagrecer quem não tem compulsão.

Bulimia nervosa

1. **TCC (padrão ouro) somada a ISRS.** A APA recomenda **fluoxetina 60 mg por dia**, desde o início ou se a terapia sozinha não funcionar após 6 semanas.
2. **Outros com alguma evidência:** sertralina, escitalopram e fluvoxamina.
3. **Menos evidência:** trazodona e topiramato.
4. Jovens com cuidador: terapia familiar.

Proibido: bupropiona, porque aumenta o risco de convulsão, que já é maior pelos distúrbios de eletrólitos da purgação. *Gancho: "quem vomita não toma bupropiona".*

Psicoterapia sozinha é melhor que remédio sozinho, e as duas juntas são melhores que cada uma.

Aulas 1, 2 e 13. O que elas trazem sobre medicamentos

Essas aulas não têm esquema de tratamento farmacológico, mas citam remédios que a prova pode cobrar.

Aulas 1 e 2 (exame do estado mental)

- **Zolpidem** pode causar **estado crepuscular**: a pessoa levanta, come, manda mensagem ou dirige e não lembra no dia seguinte.
- **Delirium** não tem remédio próprio na aula: o tratamento é achar e corrigir a causa clínica. (A Aula 6 cita a quetiapina como indicada no delirium.)

Aula 13 (dependências)

A aula trata a dependência por entrevista motivacional, estágios de mudança, internação quando há risco e redução de danos, **sem esquema de remédios**. O que ela ensina sobre fármacos é o **potencial de vício**:

- **Via oral vicia menos**, porque o efeito demora e o cérebro associa menos o ato à recompensa. Exemplos da aula: antidepressivos e lisdexanfetamina no TDAH.
- **Meia-vida curta vicia mais**, porque o nível cai rápido e gera fissura. Exemplo: midazolam, benzodiazepínico de ação curta, com mais risco de uso inadequado fora do hospital.
- **Via inalatória vicia mais**, porque o efeito é imediato, intenso e curto.

Gancho: "rápido e curto vicia; lento e oral protege".

Remédios ligados a dependência que aparecem em outras aulas: **diazepam** na abstinência alcoólica (Aula 7) e **bupropiona** no tabagismo (Aula 3).

Fonte: apostilas das Aulas 1 a 13 da pasta Psiquiatria (Mariana Freitas, turma 79A).